

The Development of Competency Assessment Model for Ophthalmic Nurse Practitioners

Jintana Paiboonthanant, M.D. *

Abstract

The author aims to study the components in the ophthalmic nurse competency and to develop a model for evaluation. There are 3 steps in the study. 1) Study the components in ophthalmic nurse practitioner competency using the Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique. 2) Develop a model for evaluating the competency of ophthalmic nurse practitioner. And 3) evaluate the model by trying in 3 government hospitals.

The results show that the competency for ophthalmic nurse practitioner can be grouped into 2 groups, specific competency and general competency. The evaluation model composes of active nursing competencies and special ophthalmic nurse competencies. When using the evaluation model in 3 hospitals, there are no statistical differences between self evaluation and evaluation by others.

Keywords: competency, evaluation, ophthalmic nurse

การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, พ.บ. *

บทสรุป:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา สร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ด้วยเทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย จักษุแพทย์ อาจารย์พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาระดับ ผู้บริหารและพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ระดับปฏิบัติ จำนวน 17 คน มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด จะถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะพยาบาล เวชปฏิบัติ ทางตา (2) นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เนื้อหา สร้างประเด็น ข้อคำถามกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ แสดงความคิดเห็นระดับความสำคัญของสมรรถนะแต่ละข้อ และ(3) นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่า มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน คำตอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณ หาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อสรุปเป็นสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการประเมิน สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและสร้างคู่มือประกอบการประเมินสมรรถนะ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โดยนำรูปแบบประเมินที่ได้ไปทดลองใช้จริงในโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 113 ข้อ เป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญมากที่สุด 106 ข้อ และระดับความสำคัญมาก 7 ข้อ สมรรถนะ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จำแนกเป็น 2 กลุ่ม 9 ด้าน ดังนี้

1.1 สมรรถนะเฉพาะทาง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 12 ข้อ (2) ด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูง ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 29 ข้อ และ (3) ด้านการพยาบาลเชิงรุก ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 9 ข้อ

1.2 สมรรถนะทั่วไป ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 9 ข้อ (2) ด้านการวิจัยประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 6 ข้อ (3) ด้านภาวะผู้นำ ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 10 ข้อ (4) ด้านการจริยธรรม และคุณธรรม ประกอบด้วยสมรรถนะจำนวน 8 ข้อ (5) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 16 ข้อ และ (6) ด้านการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 11 ข้อ

2. รูปแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูง ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 24 ข้อ และด้านการพยาบาลเชิงรุก ประกอบด้วยสมรรถนะ จำนวน 6 ข้อ

3. นำรูปแบบประเมินที่ได้ไปทดลองใช้ประเมินในโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง จำนวน 15 ท่าน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ในการประเมินตนเอง และผู้อื่น ประเมินไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในทุกข้อรายการประเมิน

*กลุ่มงานจักษุ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเรื้อรัง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ปี 2549-2550 พบว่าอัตราตาบอดอยู่ที่ ร้อยละ 0.59 และสายตาเลือนราง เท่ากับร้อยละ 1.57 ประมาณการณ่ว่าประเทศไทย มีคนตาบอด 369,013 รายและสายตาเรื้อรัง 987,992 ราย สายตาดัดผิดปกติโดยไม่มีแว่นสายตาใส่ เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของความพิการทางสายตารองลงมา คือ ต้อกระจก (วัฒเนย์ เยนจิตร และคณะ, 2551, หน้า 11) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่ว่าการพัฒนาระบบสุขภาพในปัจจุบันเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาแก่บุคลากร หน่วยงานองค์กร และภาคีการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งเผยแพร่รายงานด้านการติดตามประเมินผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยทางตา ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เน้นสมรรถนะ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548, หน้า 13) จากการ ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ของจินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ (2546)

พบว่า สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตามี 8 ด้าน ดังนี้ คือ (1) สมรรถนะด้านการพยาบาลทั่วไป (2) สมรรถนะด้านการพยาบาลทางตาระดับสูง (3) สมรรถนะด้านที่เป็นที่ปรึกษา (4) สมรรถนะด้านการวิจัย (5) สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (6) สมรรถนะด้านจริยธรรมและคุณธรรม (7) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (8) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี แต่ยังไม่มีการสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา วิธีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจำเป็นที่พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และติดตามกำกับผลการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดตัวชี้วัดจากสมรรถนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะด้วยวิธี การวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบันที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ผลการประเมินสมรรถนะจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการพัฒนาความสามารถที่พึงประสงค์ได้ เพื่อให้ได้บุคลากรพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจต่อการได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะงานการพยาบาลทางตา ซึ่งมีลักษณะงานเฉพาะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จึงต้องประเมินด้วยการวัดสมรรถนะเชิงวิชาชีพเฉพาะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการประเมิน สมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างคุณค่าให้กับวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
2. เพื่อสร้างรูปแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
3. เพื่อประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

วิธีการดำเนินการวิจัย

มีวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ดำเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)

เทคนิค EDFR ประกอบด้วยการดำเนินการ 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

รอบที่ 2 นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สร้างประเด็นข้อคำถามกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นระดับความสำคัญของสมรรถนะแต่ละข้อ

รอบที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐานค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันคำตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยพิจารณาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่ผู้เชี่ยวชาญมี ความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ ค่ามัธยฐานมีค่า 3.50 ขึ้นไป พิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 นำมาสรุปเป็นสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา นำองค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่ศึกษาเลือกเฉพาะด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูง มี 24 ข้อซึ่งเป็นสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตาและการพยาบาลเชิงรุกมี 6 ข้อ โดยเป็นสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มาสร้างรูปแบบประเมินสมรรถนะ

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา นำรูปแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ประเมินพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 3 โรงพยาบาลของรัฐที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาปฏิบัติงาน โรงพยาบาลลพบุรี จำนวน 7 คน โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 5 คน โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ จำนวน 3 คน รวม 15 คน โดยประเมินตนเองและผู้อื่นประเมิน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 17 ท่าน ได้องค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 9 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการพยาบาลทั่วไป (2) ด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูง (3) ด้านการพยาบาลเชิงรุก (4) ด้านเป็นที่ปรึกษา (5) ด้านการวิจัย (6) ด้านภาวะผู้นำ (7) ด้านการจริยธรรมและคุณธรรม (8) ด้านการบริหารจัดการ (9) ด้านการใช้เทคโนโลยี

ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จากองค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา คือ ด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูง ประกอบด้วย สมรรถนะจำนวน 24 ข้อ และ ด้านการพยาบาลเชิงรุก ประกอบด้วย สมรรถนะจำนวน 6 ข้อ และสร้างคู่มือประกอบการประเมิน

ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาในการประเมินตนเองและผู้อื่นประเมินไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในทุกข้อรายการประเมิน

อภิปรายผลการวิจัย

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยประการแรก เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา วัตถุประสงค์ประกอบที่จำเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 11 ข้อ และมีความสำคัญมาก 1 ข้อ เพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาก็คือ พยาบาลวิชาชีพสมรรถนะดังกล่าว เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวิชาชีพได้ชัดเจน บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาคือ ความเป็นอิสระ มากขึ้นและสามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจ สิทธิของผู้ใช้บริการ คำนึงถึงความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาคือต้องให้การพยาบาลแบบองค์รวม (A Royal College of Nursing,

1. ด้านการพยาบาลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับสมรรถนะ ด้านการพยาบาลทั่วไป 12 ข้อ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญมากที่สุด 11 ข้อ และมีความสำคัญมาก 1 ข้อ เพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาก็คือ พยาบาลวิชาชีพสมรรถนะดังกล่าว เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวิชาชีพได้ชัดเจน บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาคือ ความเป็นอิสระ มากขึ้นและสามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจ สิทธิของผู้ใช้บริการ คำนึงถึงความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาคือต้องให้การพยาบาลแบบองค์รวม (A Royal College of Nursing,

2. ด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูง ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นทั้งหมด 29 ข้อ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมากที่สุดทั้งหมด เพราะการพยาบาลทางตาขั้นสูง ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตา ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางตา จึงสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทางตาได้อย่างถูกต้อง ป้องกันภาวะตาบอดหรือลดความพิการทางตา

3. ด้านการพยาบาลเชิงรุก ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นทั้งหมด 9 ข้อ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมากที่สุด 7 ข้อ และสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมาก 2 ข้อ เพราะ ปัญหาผู้ป่วยทางตามีเพิ่มมากขึ้น และบางโรคสามารถป้องกันหรือลดอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกหรือได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ทั้งยังประหยัดงบประมาณค่ารักษาลง และป้องกันภาวะตาบอดซึ่งเป็นภาระของ สังคมและประเทศชาติตามมา

4. สมรรถนะด้านเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเป็นที่

ปรึกษา 11 ข้อ เป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาคือมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะทางตาดังนั้น พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาคือจะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เป็นที่เลี้ยงแก่พยาบาลที่มาปฏิบัติงานในแผนกจักษุได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มีปัญหาทางตา

5. สมรรถนะด้านการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในสมรรถนะ 6 ประการว่ามีความสำคัญระดับมากที่สุด 2 ข้อ และเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมาก 4 ข้อ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสมรรถนะด้านการวิจัยนั้นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาส่งผลให้ความรู้และทักษะในการทำวิจัย อีกทั้งภาระงานประจำวันมีมาก จึงไม่มีเวลาในการทำงานวิจัย แต่ด้วยความสำคัญของการวิจัยที่สามารถพัฒนางานการพยาบาลทางตา ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงให้ความสำคัญกับสมรรถนะด้านนี้

6. สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ 11 ข้อ เป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมากที่สุด 10 ข้อ และเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมาก 1 ข้อ ทั้งนี้เนื่องจาก พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาคือต้องเป็นผู้นำการพยาบาลทางตา และส่งเสริมสุขภาพตา

7. สมรรถนะด้านจริยธรรมและคุณธรรม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับสมรรถนะด้านจริยธรรมและคุณธรรม 8 ข้อ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมากที่สุดทุกข้อ เนื่องจาก วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วย จริยธรรมมีความสำคัญสูงสุด

8. สมรรถนะด้านบริหารจัดการ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับสมรรถนะด้านบริหารจัดการ 16 ข้อ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมากที่สุดทั้งนี้ เป็นเพราะว่า งบประมาณที่จ่ายให้สถานพยาบาล ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการเหมาจ่ายรายหัวหรือจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรครวม เป็นระบบที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลลัพธ์การลงทุน จากภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่งบประมาณลดลง พยาบาลเวชปฏิบัติทางตามีส่วน

ช่วยในการบริหารจัดการด้านการพยาบาลทางตาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะผู้บริหารงานพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

9. สมรรถนะด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 11 ข้อ เป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมากที่สุดจำนวน 10 ข้อ และเป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญระดับมากจำนวน 1 ข้อ ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องมือพิเศษทางตาพัฒนาก้าวหน้ามาก พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาต้องมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการปฏิบัติงาน ดังที่ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ได้เสนอว่าควรรู้จักใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ควรมีทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารและศึกษาข้อมูล

จากวัตถุประสงค์การวิจัยประการที่สอง เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ผู้วิจัยต้องการศึกษาสมรรถนะจำเป็นเฉพาะทางตาจึงนำมาสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาโดยแบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ มีทักษะทัศนคติและมีความคิดวิจารณ์ญาณ มีการบูรณาการความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานบนพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ของบุคคลทั่วไป ในการประเมินผู้ประเมินต้องการมีส่วนร่วมกับผู้ถูกประเมินทำให้ใช้เวลาในการประเมินลดลงและสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และนำไปใช้ วางแผนการพัฒนาวิชาชีพ (Nutbrown, 2006, p. 36) ซึ่งพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะทางตา การกำหนดพฤติกรรมที่บ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสามารถที่กำหนดขึ้น เพราะพฤติกรรมที่กำหนดขึ้นมานี้จะเป็นดัชนีที่ใช้วัดหรือประเมินว่าความสามารถคน ๆ หนึ่งแตกต่างไปจากอีกคนหนึ่งหรือไม่ (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์, 2549) และด้านการพยาบาลเชิงรุก พยาบาลเวชปฏิบัติทางตามีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพตาในชุมชน สร้างให้เป็นชุมชนสุขภาพตาดีซึ่งสอดคล้องกับแผน พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเน้น

การส่งเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากวัตถุประสงค์การวิจัยประการที่สาม เพื่อประเมินรูปแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาโดยนำไปทดลองใช้จริง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จำนวน 15 ท่าน ในการประเมินตนเองของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาผู้อื่นประเมินนั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกข้อรายการขององค์ประกอบสมรรถนะของพยาบาลเวช ปฏิบัติทางตา ทั้งด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูงและด้านการพยาบาลเชิงรุก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่สร้างขึ้นนั้นมีความเที่ยงตรง สามารถนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

1. กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2539). การบริหารหอผู้ป่วย. กรุงเทพฯ:โพธิ์ไคเมชั่น อี เอ็ม. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 2546-2550.
2. จินตนา ไพบูลย์นันทน์. (2546). การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา. ปรินทิพนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. บุญใจ ศิริสถิตย์นรากร. (2543). การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. ปรินทิพนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
4. ปราณี สงวนชื่อ. (2547). การพัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. ปรินทิพนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5. พงษ์รัตน์ บุญญานุรักษ์. (2544). ก้าวใหม่สู่บทบาทใหม่ในการบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ: วังใหม่บลูพริ้นต์.
6. รัตนา ทองสวัสดิ์. (2541). วิชาชีพการพยาบาลประเด็นและแนวโน้ม. พิมพ์ครั้งที่ 5. เชียงใหม่: ธนบรรณ.

7. วัฒนีย์ เย็นจิตร. (2551). โครงการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนรางและโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ปี 2549-2550 รวมทั้งการประเมินสมรรถภาพความพิการทางการมองเห็น. วารสารจักษุสาธารณสุข, 20(1), 124.
8. ศิริพร ตันติพลูนิย์. (2539). การพยาบาลในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, (3) (กรกฎาคม 2538-ธันวาคม 2538), 1-8.
9. ลิวลี ศิริไล. (2548). จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
10. สภาการพยาบาล. (2551). ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. การประชุมวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ สภาการพยาบาล. [เอกสารอัดสำเนา]
11. อารณ ภูววิทยาพันธุ์. (2549). Competency dictionary. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์.
12. A Royal College of Nursing. (2005). Competencies: An integrated career and competency framework for ophthalmic nursing. Retrieved December 14, 2007, from <http://www.rcn.org.uk/publications/pdf/RCNCompetenciesOphthalmicNursing.pdf>
13. American Academy of Nurse Practitioner. (2007). Why choose a nurse practitioner as your healthcare provider. Retrieved May 14, 2008, from <http://www.npfinder.com/fag.pdf>
14. Annand, F. (1997). The mentor commitment. Retrieved November 18, 2007, from <http://lib.bioinfo.pl/>
15. Asiam, S. A., Sheth, H. G., & Vaughan, A. J. (2006). Emergency management of corneal injuries. Retrieved December 13, 2007, from <http://www.injuryjournal.com/article/PIIS0020138306003020>
16. Australian Nursing and Midwifery Council. (2004). National competency standards for the nurse practitioner. Retrieved June 18, 2008, from <http://www.anmc.org.au/duch/competency-stands-for-the-nurse-practitioner.pdf>
17. Ezra, D. G. , Mellington, F. , Cugnoni, H. and Westcott, M. (2005). *Reliability of ophthalmic accident and emergency referrals : a new role for the emergency nurse practitioner*. Abstract retrieved April 11, 2008, from <http://www.Daniel.ezra@hotmail.com>
18. Ilango, B. , McGalliard, J. N. & Hughes, A. (2000). The role of nurse practitioners in a primary care eye clinic. *Accident & Emergency Nursing*, 8(1), 42-45.
19. Kirkwood, B. J., Closter, D. J., & Essex, R. W. (2006). Ophthalmic nurse practitioner led diabetic retinopathy screening: Results of a 3-month trial. Retrieved May 10, 2008, from <http://www.Kirkwood70@hotmail.com>
20. Nutbrown, S. (2006). Appraisals/development reviews: appraising others. *Journal of Practice Nurse*, 31(2), 36.
21. Romaine-Davis, A. (1997). *Advanced practice nurses*. Boston: Sudbury. Rose, K., Waterman, H., Mcleod, D., & Tullo, A. (2001). *Planning and managing research into day-surgery for cataract*. Retrieved September 25, 2008, from <http://www.3.interscience.wiley.com/journal/119093460/abstract?CRETRY=1&SERTRY=0>
22. School of Health Sciences. (2008). *Advanced Diploma in Nursing (Ophthalmic)*. Retrieved September 15, 2008, from http://www.SHS/cet_advdp_nr_opht.html
23. Tolley, F. M., & Navarro, V. B. (1996). The virtual ophthalmic nurse: A reality. Retrieved November 18, 2007, from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8954366>